

REALIMENTAÇÃO — DEVAGAR + TIAMINA + ELETRÓLITOS

O QUE É E POR QUE ACONTECE

Aspecto	Detalhe
Definição	Distúrbios hidroeletrolíticos graves ao reintroduzir nutrição em paciente desnutrido/jejum prolongado
Gatilho	Carboidrato -> pico de insulina -> entrada de fósforo, potássio e magnésio para dentro da célula
Marcador-chave	HIPOFOSFATEMIA (geralmente em 12-72h do início da dieta)
Outros distúrbios	Hipopotassemia, hipomagnesemia, retenção de sódio/água, deficiência de tiamina
Consequências	Arritmia, IC, insuficiência respiratória, rabdomiólise, convulsão, encefalopatia de Wernicke, morte
Início dos sintomas	Tipicamente nos primeiros 2-5 dias da realimentação

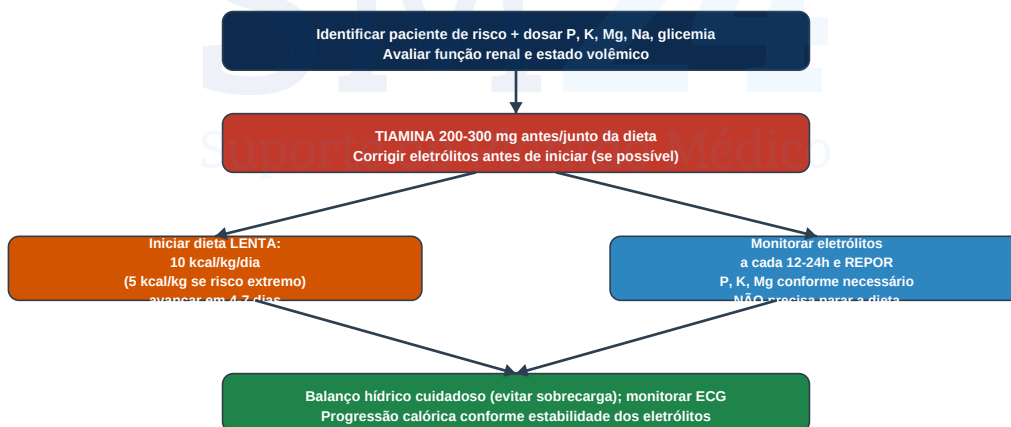
QUEM ESTÁ EM RISCO (CRITÉRIOS NICE)

IDENTIFICAR ANTES DE ALIMENTAR

- ALTO RISCO (1 critério maior): IMC < 16; perda de peso > 15% em 3-6 meses; ingestão alimentar mínima > 10 dias; K, P ou Mg baixos antes de alimentar
- ALTO RISCO (2 critérios menores): IMC < 18,5; perda de peso > 10%; ingestão mínima > 5 dias; história de álcool ou drogas (incluindo insulina, quimioterapia, antiácidos, diuréticos)
- Grupos clássicos: anorexia nervosa, alcoolismo crônico, desnutrição grave, pós-bariátrica, neoplasia, greve de fome, idoso negligenciado
- Reconhecer o risco é o passo mais importante — a síndrome é PREVENÍVEL
- Dosar P, K, Mg, Na, glicemia e função renal ANTES de iniciar a dieta
- Repor tiamina ANTES de qualquer aporte de glicose (prevenir Wernicke)

PREVENÇÃO E MANEJO

REALIMENTAR COM SEGURANÇA



REPOSIÇÃO E SUPORTE

Rx TIAMINA, FÓSFORO, POTÁSSIO E MAGNÉSIO

Tiamina: 200-300 mg/dia IV/VO antes de iniciar a dieta e por pelo menos 3 dias (mais se etilista) — previne Wernicke

Fósforo: repor se P baixo; grave/sintomático -> fosfato IV (ex.: fosfato de potássio 0,3-0,6 mmol/kg em 6-12h)

Potássio: repor conforme nível; monitorar ECG; cuidado em disfunção renal

Magnésio: sulfato de magnésio IV se hipomagnesemia (também facilita a correção de K+)

Complexo B e multivitamínico/oligoelementos durante a realimentação

Dieta: iniciar 10 kcal/kg/dia (5 kcal/kg em risco extremo) e avançar gradualmente em 4-7 dias

NÃO administrar grande carga de glicose/soro glicosado sem tiamina prévia

ERROS COMUNS E WERNICKE

Erros que Matam

- Alimentar/soro glicosado em desnutrido sem repor tiamina antes
- Iniciar dieta plena (alvo calórico total) no primeiro dia
- Não dosar P, K e Mg antes e durante a realimentação
- Confundir a fraqueza/dispneia da síndrome com a doença de base
- Sobrecarga de volume em paciente com função cardíaca comprometida

Encefalopatia de Wernicke

- Tríade: confusão + oftalmoplegia/nistagmo + ataxia (raramente completa)
- Precipitada por glicose sem tiamina em paciente de risco
- Tratamento: tiamina IV em dose alta (ex.: 500 mg 8/8h por 2-3 dias)
- Prevenção é prioridade no etilista e desnutrido
- Não aguardar exames para repor tiamina

PROTOCOLO PRÁTICO

PASSO A PASSO

- ☐ Rastrear risco (critérios NICE) em todo desnutrido/jejum prolongado/etilista
- ☐ Dosar P, K, Mg, Na, glicemia e função renal antes de iniciar a dieta
- ☐ Tiamina 200-300 mg antes de qualquer aporte calórico/glicose
- ☐ Iniciar dieta lenta (10 kcal/kg/dia; 5 se risco extremo) e progredir em 4-7 dias
- ☐ Monitorar e repor eletrólitos a cada 12-24h (não é necessário suspender a dieta para repor)
- ☐ Vigiar balanço hídrico e ECG; suporte multivitamínico durante a realimentação

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual é o distúrbio eletrolítico MARCADOR da síndrome de realimentação?

- A) Hipernatremia
- B) Hipofosfatemia
- C) Hipercalcemia
- D) Hipercalcemia
- E) Hipocloremia

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente etilista desnutrido será internado. Qual conduta deve preceder a administração de soro glicosado?

- A) Administrar insulina
- B) Repor tiamina
- C) Iniciar dieta plena imediatamente
- D) Administrar grande volume de glicose hipertônica
- E) Repor sódio em bolus

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual a velocidade adequada para iniciar a oferta calórica em paciente de alto risco para síndrome de realimentação?

- A) Alvo calórico total no primeiro dia
- B) Iniciar com cerca de 10 kcal/kg/dia (5 kcal/kg em risco extremo) e progredir em 4-7 dias
- C) Jejum prolongado até normalizar os eletrólitos
- D) 30 kcal/kg/dia desde o início
- E) Apenas nutrição parenteral plena

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Durante a realimentação, o fósforo sérico cai e o paciente apresenta fraqueza muscular. Qual a conduta?

- A) Suspender definitivamente a dieta
- B) Repor fósforo (e demais eletrólitos) e manter a dieta em velocidade reduzida, com monitoração
- C) Aumentar rapidamente a oferta calórica
- D) Administrar apenas potássio
- E) Iniciar diurético

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

A administração de glicose sem reposição de tiamina em paciente de risco pode precipitar qual complicação?

- A) Encefalopatia de Wernicke
- B) Hipertireoidismo
- C) Pancreatite
- D) Cetoacidose diabética
- E) Insuficiência adrenal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A hipofosfatemia é o marcador-chave da síndrome de realimentação. Com a reintrodução de carboidratos, a insulina desloca fósforo (e potássio e magnésio) para o intracelular, podendo causar arritmia, insuficiência respiratória e rabdomiólise.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Em paciente etilista/desnutrado, a tiamina deve ser repostada ANTES de qualquer aporte de glicose, para prevenir a encefalopatia de Wernicke, que pode ser precipitada pela glicose em paciente deficiente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Em alto risco, iniciar a oferta calórica de forma lenta (cerca de 10 kcal/kg/dia, ou 5 kcal/kg em risco extremo) e progredir gradualmente em 4-7 dias, com monitoração e reposição de eletrólitos, previne a síndrome de realimentação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na queda do fósforo com sintomas, deve-se repor o fósforo e os demais eletrólitos e manter a dieta em velocidade reduzida com monitoração frequente — não é necessário suspender a nutrição, apenas ajustá-la enquanto se corrigem os distúrbios.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Glicose sem tiamina em paciente de risco (etilista, desnutrado) pode precipitar a encefalopatia de Wernicke (confusão, oftalmoplegia, ataxia). Por isso a tiamina deve sempre preceder o aporte de glicose nesses pacientes.

SM24
Suporte ao Plantão Médico